

GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE

Bonjour, **ERIC ABDOUL ISMAEL**. Lorsque vous soumettez ce formulaire, le propriétaire verra votre nom et votre adresse e-mail.

1. Les règles durent en moyenne 4 à 5 jours.

(1 point)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

2. L'accrochage des mentons au cours d'un accouchement gémellaire peut survenir si J1 est en présentation céphalique et J2 en présentation du siège.

(1 point)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

3. L'HTA au cours de la grossesse est la deuxième cause de mortalité maternelle.

(1 point)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

4. La phase folliculaire est sous la dépendance des oestrogènes.

(1 point)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

5. Parmi les propositions suivantes, deux situations se retrouvent dans le premier retard : lesquelles ?

(1 point)

- ☐ Retard d'exécution des soins
- ☐ Méconnaissance des signes de danger
- ☐ Insuffisance de personnel
- ☐ Insuffisance de moyens de référence adéquate
- ☐ Faible pouvoir de décision de la femme

6. Quelle manœuvre est réalisée en cas de rétention de la tête dernière lors d'un accouchement de siège ?

(1 point)

- ☐ Manoeuvre de bracht
- ☐ Manoeuvre de lovset
- ☐ Manoeuvre de Mauriceau
- ☐ Attitude de vermellin

7. Laquelle de ces présentations est considérée comme hautement dystocique ?

(1 point)

- ☐ Présentation du sommet
- ☐ Présentation du bregma
- ☐ Présentation du front
- ☐ Présentation du siège

8. Quel est le degré de procidence où le cordon est extériorisé à la vulve ?

(1 point)

- ☐ Degré I
- ☐ Degré II
- ☐ Degré III
- ☐ Degré IV

9. À quelle phase du travail peut survenir une dilatation stationnaire ?

(1 point)

- ☐ Phase de latence uniquement
- ☐ Phase active
- ☐ Les deux phases
- ☐ Phase de délivrance

10. Quelle est l'origine principale du liquide amniotique pendant la grossesse ?

(1 point)

- ☐ Exsudation à travers les membranes
- ☐ Urines du fœtus
- ☐ Sueur de la mère
- ☐ Transfusion sanguine

11. Quel est l'un des objectifs du traitement de la grossesse extra-utérine ?

(1 point)

- ☐ Augmenter le taux de BHCG
- ☐ Préserver la fertilité
- ☐ Accélérer la croissance du fœtus
- ☐ Permettre la migration de l'œuf dans l'utérus

12. Vous recevez dans votre centre de santé urbain une primipare dilatée à 3 cm avec un fœtus présentant une souffrance fœtale aigue, deux attitudes sont à réaliser; lesquelles ?

(1 point)

- ☐ Hâter l'accouchement par voie basse par une perfusion d'ocytocique
- ☐ Administrer le sérum glucosé hypertonique à 10%
- ☐ Faire une extraction instrumentale
- ☐ Référer en urgence la parturiente vers un centre obstétrico-chirurgical
- ☐ Il n'est pas nécessaire de faire une réanimation néonatale

13. Deux propositions sont exactes concernant les grossesses gémellaires bi-ovulaires : lesquelles ?

(1 point)

- ☐ Elle est toujours bi choriale bi amniotique
- ☐ Les fœtus sont toujours de même sexe
- ☐ Ce sont des faux jumeaux
- ☐ Les fœtus sont toujours de sexe différent
- ☐ Elle peut donner naissance à des siamois

14. Concernant le cordon ombilical : deux assertion sont fausses; lesquelles ?

(1 point)

- ☐ Il contient 3 vaisseaux
- ☐ Il contient un nerf
- ☐ Il contient deux artères et une veine
- ☐ Il contient deux veines et une artère
- ☐ Il mesure en moyenne 60 cm

15. Le phénomène transfuseur/ transfuser se retrouve dans une des situations suivantes : laquelle ?

(1 point)

- ☐ Chez des jumeaux de sexes différents
- ☐ Dans la grossesse gémellaires bi ovulaire
- ☐ Dans la grossesse gémellaires bi choriale bi amniotique
- ☐ Dans les grossesses gémellaires mono choriale bi amniotique

16. Laquelle de ces propositions est exacte, concernant le placenta ?

(1 point)

- ☐ Le cordon ombilical s'insère sur la face maternelle
- ☐ Il pèse en moyenne 1/6 du poids du fœtus à terme
- ☐ La face fœtale est charnue et contient des cotylédons
- ☐ Il permet de maintenir la grossesse dès la fécondation de l'œuf

17. L'une des propositions suivantes ne se retrouve pas dans la présentation de l'épaule négligée; laquelle ?

(1 point)

- ☐ Le fœtus est le plus souvent vivant
- ☐ Elle fait partie des présentations transversales
- ☐ On retrouve une procidence du bras
- ☐ Infection ovulaire probable

18. Parmi les présentations suivantes, l'une a pour diamètre d'engagement; le diamètre occipito frontal : laquelle ?

(1 point)

- ☐ Présentation du front
- ☐ Présentation du sommet
- ☐ Présentation du bregma
- ☐ Présentation de la face

ÉTUDE DE CAS CLINIQUE

Vous êtes une Sage-femme nouvellement affectée dans un CSU. Vous consultez Mme KOUE, âgée de 24 ans, G3P1, hypertendue connue, lors de sa première consultation à 33 semaines d'aménorrhée. L'interrogation révèle des céphalées en casque associées à un flou visuel. À l'admission, les résultats montrent une tension artérielle à 15/8 mmHg, protéinurie++.

19. À quel diagnostic pensez-vous ?

(1 point)

- ☐ HTA gravidique
- ☐ Pré éclampsie
- ☐ HTA chronique
- ☐ Pré éclampsie surajoutée

20. 15 minutes après son admission, elle présente une crise convulsive ; il s'agit d'une :

(1 point)

- ☐ Pré éclampsie sévère avec signe d'eclampsisme
- ☐ Crise hystérie
- ☐ Crise d'eclampsie
- ☐ Crise d'épilepsie

21. N'ayant jamais assisté à un tel événement, vous contactez votre médecin référent qui vous donne des instructions, parmi ces instructions, vous décidez de suivre deux; lesquelles ?

(1 point)

- ☐ Appeler à l'aide
- ☐ Mettre une compresse dans la bouche de la patiente
- ☐ La mettre en position latérale de sécurité
- ☐ L'attacher au lit
- ☐ Administrer 5 cc de valium en IM

22. Après avoir validé votre décision, il vous demande de faire un traitement pré transfert. Quelle molécule allez-vous utiliser en première intention ?

(1 point)

- ☐ Valium
- ☐ Celestène
- ☐ Sulfate de magnésium
- ☐ Gardenal

23. Quelle est la dose de charge à administrer en IM ?

(1 point)

- ☐ 4 grammes
- ☐ 5 grammes
- ☐ 10 grammes.
- ☐ 14 grammes

24. En attendant l'ambulance pour son transfert, vous décidez de surveiller la patiente, quels sont les deux paramètres les plus importants de cette surveillance ?

(1 point)

- ☐ La fréquence cardiaque
- ☐ La température
- ☐ La fréquence respiratoire
- ☐ L'état de conscience
- ☐ La tension artérielle

25. La patiente est admise 3h du temps après à l'hôpital général de référence. D'après vous quelle serait la conduite à tenir dans le centre de référence ?

(1 point)

- ☐ Hospitaliser la patiente pour une meilleure surveillance de la grossesse
- ☐ Préconiser un déclenchement en vue d'un accouchement par voie basse
- ☐ Réaliser une césarienne en urgence
- ☐ Faire une maturation pulmonaire et prévoir l'intervention à la 36 S.A

26. Elle donne naissance à un prématuré pesant 1300 grammes, APGAR 5,6 : il s'agit d'un(e) :

(1 point)

- ☐ Bon état initial
- ☐ État de mort apparente
- ☐ Dépression respiratoire immédiate

27. Quels seront les deux gestes à réaliser dans ce cas ?

(1 point)

- ☐ Désobstruction des voies aériennes
- ☐ Massage cardiaque externe
- ☐ Administrer d'adrénaline
- ☐ Ventilation externe
- ☐ Intubation trachéale

28. Lors de la surveillance, Mme KOUE demande à la Sage-femme en salle de réveil de surélever la tête du lit car elle arrive difficilement à respirer. Elle présente une toux avec des crachats mêlés à du sang. À quel diagnostic pensez-vous ?

(1 point)

- ☐ Une tuberculose pulmonaire
- ☐ Une crise d'asthme
- ☐ Un œdème aigu du poumon
- ☐ Une embolie pulmonaire

29. Quel geste important aurait dû être réalisé par la Sage-femme ayant reçu la patiente dans le CSU et qui aurait pu prévenir cette complication ?

(1 point)

- ☐ La prise d'une bonne voie veineuse avant son évacuation
- ☐ La surveillance de la tension artérielle de la fréquence respiratoire et du pouls régulièrement
- ☐ La mise en place d'une sonde urinaire
- ☐ La mise en place d'une canule de GUEDEL dans la bouche

30. Le protocole mis en place permet de stabiliser la patiente. Une heure après, l'aide soignante voulant nettoyer la patiente constate que tous les draps sont imbibés de sang et vous alerte, votre examen retrouve une voie non perméable. T.A : 8/6 cmHg et un pouls à 112 Bts/ min. Il s'agit probablement d'une hémorragie du post-partum immédiat par :

(1 point)

- ☐ Rétention placentaire
- ☐ Coagulopathie
- ☐ Déchirure du col
- ☐ Atonie utérine

31. Quelle serait votre conduite à tenir en urgence ?

(1 point)

- ☐ L'ablation de l'utérus
- ☐ Perméabiliser de la voie veineuse
- ☐ Faire une délivrance artificielle
- ☐ Mettre un tamponnement intra-utérin par ballonnet

32. Tout se passe bien et après 5 jours d'hospitalisation vous prévoyez sa sortie après un counseling en planification familiale. Quelle méthode peut-elle utiliser avant sa sortie de l'hôpital ?

(1 point)

- ☐ Le dispositif intra-utérin
- ☐ Les injectables à un seul progestatif
- ☐ L'implant
- ☐ Les injectables combinés